

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: MARÍA ISABELLA GARCÍA CASTRO	H.C: 1067632311
EDAD: 9 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 16/06/2016
ESCOLARIDAD: Segundo grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 26,27/11/2025
DIRECCION: CRA 18d # 49-146	CORREO: Lottys_2110@hotmail.com
EPS: Particular	SEXO: F
ACOMPAÑANTE: Padres	CELULAR: 3188944736
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Psicología	

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, principalmente queremos ver si existe un retraso en la parte cognitiva, esta adelantada a su edad biológica.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde transición (5 años); caracterizado por que no le va bien en idiomas, la paciente comenta a la madre por que es la niña mas grande del salón, los compañeros tienen un promedio de 7 años, confunde la b con la d, tiende a omitir palabras en escritura y lectura, acompañado de dificultades en la comprensión lectora, no le va bien en los exámenes que suelen ser de selección múltiple, tiene los dos pies hacia dentro, (marcha convergente o marcha en adducción), suele responder preguntas con temas no relacionados, cambia los temas, habla todo el tiempo, saltándose de temas, (fuga de ideas), en ocasiones se compara con los hermanos, ha expresado preguntas, de por qué los hermanos han logrado ciertas cosas y ella no, la madre ha observado que cuando se le prometen cosas mejora su rendimiento, existen quejas escolares como no sentarse en el salón de clase, no hablar casi, desconcentrarse con facilidad.

Cuando el padre le enseña los ejercicios en matemáticas, comprende los conceptos per cuando se le pregunta los olvida.

I. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

II. ANTECEDENTES PERSONALES

Existe antecedente de Prematura de 35 semanas, tuvo en UCI a los 2 1/2, donde adquirió bacteria, por un tiempo de dos meses.

Tuvo cirugía de tibia derecha por osteomielitis, con múltiples alergias.



ENFERMEDAD MEDICA: NO REPORTA.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, inadecuada higiene postural, orientada a lo y auto psíquicamente, lenguaje fluido, taquilalia, taquipsiquia, distractiva, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.

PRUEBAS APLICADAS

Se realizó prueba cognitiva Escala de inteligencia de Wechsler para niños V: Atención, Claves del Wisc V, Búsqueda de símbolos del Wisc V: Memoria: Dígitos del Wisc V dígitos en orden directo, inverso y creciente, Span de dibujos del Wisc V, Lenguaje: Semejanzas del Wisc V, Vocabulario.

Se realizó evaluación neuropsicológica aplicando batería de la ENI 2: 1. Habilidades Gráficas (praxias), 2. Memoria auditiva verbal codificación, 3. Memoria visual codificación, 4. Memoria evocación verbal diferida, 5. Memoria evocación visual diferida, 6. Habilidades perceptuales, 7. lenguaje Repetición, Expresión, Comprensión, 8. Atención, 9. Función Ejecutiva.

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada



Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica

Año Mes Día

Fecha de aplicación

2025 11 26

Fecha de nacimiento

2016 6 16

Edad Cronológica

9 5 10

Nombre del niño:

MARÍA ISABELLA GARCÍA CASTRO

Examinador:

JAINER GUZMÁN VEGA

Página de resumen

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

Prueba	PD	Puntuación escalar					
Cubos	22		8				8
Semejanzas	13	5					5
Matrices	15			8			8
Dígitos	13				4		4
Claves	28					7	7
Vocabulario	4	1					1
Balanzas	13			7			7
Puzles visuales	15		11				(11)
Spam de dibujos	18				6		(6)
Búsqueda de Símbolos	17					7	(7)
Información						1	(1)
Letras y números	6					3	(3)
Cancelación						1	(1)
Comprensión						1	(1)
Aritmética	13					6	(6)
Suma puntuaciones escalares		6	19	15	10	14	40

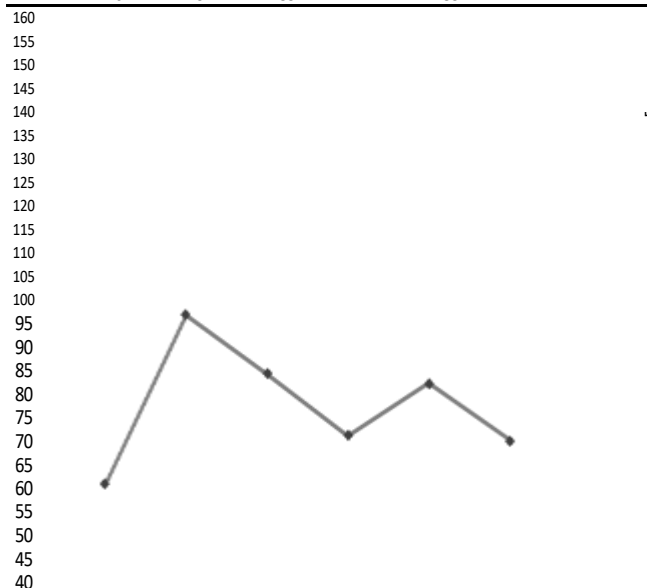
Comp. Verbal Visoes- pacial Razon. Fluído Mem. Trabajo Vel. Proces. Escala total

Perfil de puntuaciones escalares

	Comprensión verbal				visoes- pacial		Razonamiento fluído			Memoria de Trabajo			Velocidad de Procesamiento		
	S	V	I	CO	C	PV	M	B	A	D	SD	LN	CL	BS	CA
19	5	1	1	1	8	11	8	7	6	4	6	3	7	7	1
18															
17															
16															
15															
14															
13															
12															
11															
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															

Perfil de puntuaciones compuestas

	ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT
	62	97	85	72	83	71



Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta		Rango Percentil	Intervalo de confianza
					95%
Comprension Verbal	6	ICV	62	1	58-75
Visoespacial	19	IVE	97	42	89-106
Razonamiento fluido	15	IRF	85	16	79-93
Memoria de trabajo	10	IMT	72	3	66-83
Velocidad de procesamiento	14	IVP	83	13	76-94
Escala total	40	CIT	71	3	66-79



Análisis Primario

Puntos fuertes y débiles							Punto fuerte o débil	
		Puntuación	Puntuación de comparación		Diferencia	Valor crítico		
Índices	ICV	62	-	79,8	=	-17,8	8,53	F o D
	IVE	97	-	79,8	=	17,2	9,34	F o D
	IRF	85	-	79,8	=	5,2	7,62	F o D
	IMT	72	-	79,8	=	-7,8	9,71	F o D
	IVP	83	-	79,8	=	3,2	11,11	F o D
Pruebas	Semejanzas	5	-	6,4	=	-1,4	2,36	F o D
	Vocabulario	1	-	6,4	=	-5,4	2,73	F o D
	Cubos	8	-	6,4	=	1,6	2,81	F o D
	Puzles visuales	11	-	6,4	=	4,6	2,73	F o D
	Matrices	8	-	6,4	=	1,6	2,15	F o D
	Balanzas	7	-	6,4	=	0,6	1,78	F o D
	Dígitos	4	-	6,4	=	-2,4	2,26	F o D
	Span de dibujos	6	-	6,4	=	-0,4	3,21	F o D
	Claves	7	-	6,4	=	0,6	3,27	F o D
	Búsqueda de símbolos	7	-	6,4	=	0,6	3,21	F o D



Opciones de comparación de los índices

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios

MIP 399 / 5 79,8

Nivel de significación del valor crítico

Opciones de comparación de las pruebas

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales

MPE-P 64 / 10 6,4

Opciones de comparación de los índices

Nivel de significación del valor crítico

Grupo de referencia
Nivel de aptitud

Comparación entre índices/pruebas

Comparación		Puntuación 1	Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Índices	ICV-IVE	ICV 62	- IVE 97	= -35	9,84	S o N
	ICV-IRF	ICV 62	- IRF 85	= -23	8,52	S o N
	ICV-IMT	ICV 62	- IMT 72	= -10	12,12	S o N
	ICV-IVP	ICV 62	- IVP 83	= -21	11,27	S o N
	IVE-IRF	IVE 97	- IRF 85	= 12	9,20	S o N
	IVE-IMT	IVE 97	- IMT 72	= 25	10,72	S o N
	IVE-IVP	IVE 97	- IVP 83	= 14	11,79	S o N
	IRF-IMT	IRF 85	- IMT 72	= 13	9,52	S o N
	IRF-IVP	IRF 85	- IVP 83	= 2	10,72	S o N
	IMT-IVP	IMT 72	- IVP 83	= -11	12,04	S o N
Pruebas	Semejanzas-Vocabulario	S 5	- V 1	= 1	2,93	S o N
	Cubos-					
	Puzles visuales	C 8	- PV 11	= -3	2,77	S o N
	Matrices-					
	Balanzas	M 8	- B 7	= 1	2,29	S o N
	Dígitos-					
	Span de dibujos	D 4	- SD 6	= -2	2,48	S o N
	Claves-					
	Búsqueda de símbolos	CL 7	- BS 7	= 0	3,04	S o N

Opciones de comparación de las pruebas

Nivel de significación del valor crítico



La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario, balanzas). El paciente obtuvo un CIT de **70**, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **62**, se clasifica como **discapacidad leve**, estando en 3 rangos por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **97**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándolo dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **85**, se clasifica con una capacidad general **medio bajo**, estando 1 rango por debajo de lo esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información, relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento inductivo y cuantitativo a fin de identificar y aplicar reglas.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **72**, lo cual establece una capacidad **inferior**, estando 2 rangos por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental; aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente.

Velocidad de procesamiento

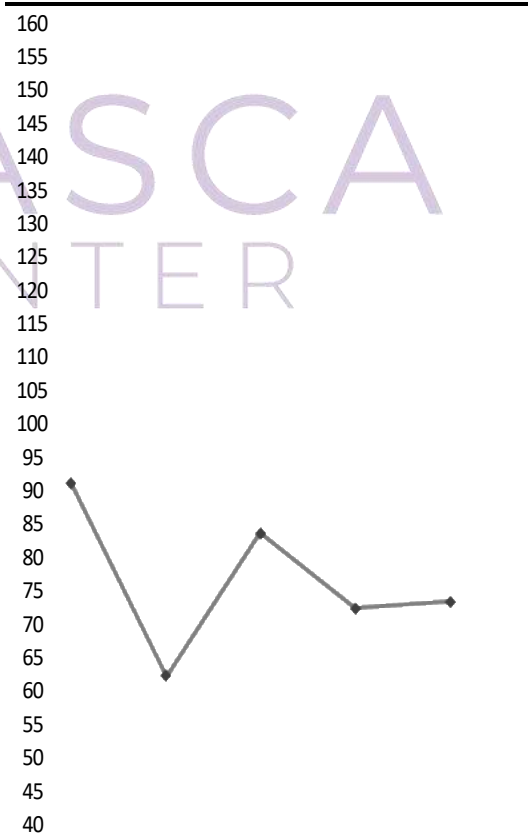
El valor obtenido en VP es de **83**, se clasifica con una capacidad general **medio bajo**, estando 1 rango por debajo de lo esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.





Análisis Secundario					
Suma de puntuaciones escalares					
Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			8	8	
Semejanzas				5	
Matrices			8	8	
Dígitos		4			4
Claves			7		7
Vocabulario				1	
Balanzas	7		7	7	
Puzles visuales			11		
Span de dibujos			6		6
Búsqueda de símbolos					7
Letras y números		3			
Aritmética	6				
Suma de puntuaciones escalares	13	7	47	29	24
	Raz. Cuantitativo	Mem. Trabajo auditivo	No verbal	Capacidad General	Competencia Cognitiva

IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	63	84	73	74



Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices					
Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	7	IMTA	63	1	58-74
No verbal	47	INV	84	14	79-91
Capacidad general	29	ICG	73	4	68-81
Competencia cognitiva	24	ICC	74	4	68-84



INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SECUNDARIOS

Razonamiento cuantitativo

El valor obtenido en IRC de 91 (entre 84-99) se sitúa en el percentil 27 y se clasifica como punto normal normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de Razonamiento cuantitativo refleja la capacidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente y comprender las relaciones cuantitativas. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió resolver mentalmente problemas aritméticos (Aritmética, Pe = 6) y en la otra se le pidió que observe una balanza a la cual le faltan pesas y seleccionar la opción que la mantiene equilibrada (Balanzas, Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas no es representativa (es decir, su amplitud es menor que 5 puntos), sin embargo las puntuaciones individuales se encuentran por debajo de lo esperado.

Memoria de trabajo auditiva

El valor obtenido en IMTA de 63 (entre 58-74) se sitúa en el percentil 27 y se clasifica como punto débil normativo / Discapacidad leve, con relación a otros niños de su edad y edad escolar.

El índice de Memoria de trabajo auditiva indica la aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió repetir una lista de cifras en el mismo orden o en orden inverso (Dígitos, Pe = 4) y en la otra se le solicitó repetir una combinación de letras y números leída previamente por el/la entrevistador/a (Letras y números, Pe = 3). La diferencia de los resultados entre las dos tareas no es grande (no llega a los 5 puntos), no obstante los resultados en IMTA establecen baja medida en a procesos relacionados con la memoria de trabajo auditiva.

No verbal

El valor obtenido en INV de 84 (entre 79-91) se sitúa en el percentil 14 y se clasifica como Punto débil normativo / Promedio Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice no verbal puede interpretarse como una medida de aptitud intelectual general que reduce al mínimo la intervención del lenguaje expresivo. El INV está conformado por 6 puntuaciones escalares de pruebas que no requieren respuestas verbales: cubos (Pe = 8), matrices (Pe = 8), claves (Pe = 7), balanzas (Pe = 7), puzzles visuales (Pe = 11) y span de dibujos (Pe = 6). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es menor a 5 puntos), sin embargo las respuestas se encuentran muy por debajo a lo esperado.

Capacidad general

El valor obtenido en ICG de 73 (entre 68-81) se sitúa en el percentil 4 y se clasifica como Punto débil normativo / Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice de capacidad general hace referencia a una estimación de la aptitud intelectual general menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el CI total. Involucra la capacidad de razonamiento abstracto y conceptual, razonamiento visoperceptivo y espacial y resolución de problemas verbales. El ICG es el resultado de 5 puntuaciones escalares: cubos (Pe = 8), semejanzas (Pe = 5), matrices (Pe = 8), vocabulario (Pe = 1) y balanzas (Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento, que establecen bajas competencias a nivel intelectual.

Competencia cognitiva

El valor obtenido en ICC de 74 (entre 68-84) se sitúa en el percentil 4 y se clasifica como punto débil normativo/ Inferior con relación a otros niños de su edad y escolaridad.



El índice de competencia cognitiva ofrece una estimación de la eficacia con la que se procesa la información durante el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento de nivel superior. El ICC es el resultado de 4 puntuaciones escalares: dígitos (Pe = 4), claves (Pe = 7), span de dibujos (Pe = 6) y búsqueda de símbolos (Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas no es inusualmente grande (es decir, su amplitud es menor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento que requieren una respuesta rápida y efectiva al igual que el procesamiento.

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2)

Rango percentil	Clasificación
>84	Superior
84	Promedio alto
26-75	Normal promedio
16	Promedio bajo
5-9	Limite
<2	Muy bajo

Habilidades Graficas (praxias)			
Dibujo de figura humana	Puntaje 12	Percentil 37	NORMAL
Copia figuras	Puntaje 8	Percentil 50	NORMAL
Mide las habilidades praxicas. Desarrollo cognitivo general. La existencia de errores de tamaño cierre y dimensiones, distorsión o rotación de las figuras. La habilidad de graficar un modelo a partir de lo visual, La capacidad de crear un modelo a partir de los recursos cognitivos, la coordinación visomanual.			
Memoria auditiva verbal codificación			
Recuerdo de una historia	Puntaje 5	Percentil 16	ANORMAL
Lista de palabras (curva de memoria)	Puntaje 25	Percentil 9	ANORMAL
Mide los procesos de memoria a corto plazo de contenido auditivo verbal, si realiza agrupación semántica, organización serial, mide la curva de aprendizaje. El máximo de evocación es 9 para niños menores de 8 años y 12 para mayores de 8 años. Mide esfuerzo cognitivo y esfuerzo al logro en tareas que requieren una mayor atención.			
Memoria visual codificación			
Figura de Rey	Puntaje 8	Percentil 2	ANORMAL
Mide las agrupaciones semánticas de figuras relacionadas geométricamente, si existe rotación de los elementos internos de las figuras, mide la curva de aprendizaje visual. Mide la capacidad de memoria a corto plazo visual.			



Mide el sistema visual y para reproducir esas imágenes mediante la motricidad grafo – manual. (sistema motor y visual)

Memoria evocación verbal diferida			
Recobro espontaneo de lista de palabras	Puntaje	Percentil	
	0	0,1	ANORMAL
Recobro por claves	Puntaje	Percentil	
	5	9	ANORMAL
Reconocimiento verbal auditivo	Puntaje	Percentil	
	21	16	ANORMAL
Recuperación de una historia	Puntaje	Percentil	
	6	26	NORMAL

Mide la existencia de errores perseverativos, de intrusión, capacidad para codificar, almacenar y evocar información a largo plazo de tipo auditiva verbal relacionada con lista de palabras.

Mide el recobro de la información a partir del uso de las claves semánticas y fonológicas.

Memoria evocación visual diferida			
Recobro espontaneo de figura de Rey	Puntaje	Percentil	
	6	26	NORMAL
Capacidad para recordar información a largo plazo de tipo visual.			

Habilidades perceptuales			
Imágenes superpuestas	Puntaje	Percentil	
	15	95	NORMAL
Cierre visual	Puntaje	Percentil	
	5	75	NORMAL

Mide las respuestas de las habilidades perceptivas de cierre visual, y percepción de figura fondo.

Lenguaje			
Silabas	Puntaje	Percentil	
	8	63	NORMAL
Palabras	Puntaje	Percentil	
	7	63	NORMAL
No palabras	Puntaje	Percentil	
	7	63	NORMAL

Mide la articulación y la repetición de silabas - no palabras y palabras.

Evalúa habilidades de pronunciación y articulación de diferentes fonemas producción del habla.

Evalúa la estructura gramatical, evalúa recepción, comprensión y expresión del lenguaje oral, procesamiento audio fonológico y componente mnésico verbal.



Lectura			
Lectura en voz alta	Puntaje	Percentil	
	10	2	ANORMAL
Evalúa la eficiencia lectora alcanzada por la persona evaluada, evalúa conversión grafema - fonema, identificación adecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación.			

Escritura			
Oraciones	Puntaje	Percentil	
	5	0,4	ANORMAL
Evalúa los procesos de segmentación fonética y recuperación de los grafemas de cada de cada palabra y la destreza manual necesaria para la escritura.			

Expresión			
Denominación de imágenes de imágenes	Puntaje bruto	Percentil	
	7	5	ANORMAL

Mide la capacidad de reconocimiento y denominación.

Comprensión			
Comprensión del discurso	Puntaje	Percentil	
	3	16	ANORMAL

Mide la habilidad comprensiva, análisis e inferencia.

Evalúa la interpretación basado en los componentes de atención, memoria y lenguaje.

Atención			
Dígitos en Progresión	Puntaje	Percentil	
	2	0,1	ANORMAL
Dígitos En Regresión	Puntaje	Percentil	
	2	5	ANORMAL

Mide la atención auditiva sostenida y focalizada.

Mide las respuestas de memoria de trabajo.

Función Ejecutiva			
Fluidez Semántica	Puntaje	Percentil	
Frutas	7	9	ANORMAL
animales	12	16	ANORMAL
Fluidez Fonológica	Puntaje	Percentil	
	6	26	NORMAL

Mide si el paciente realiza intrusiones, perseveraciones, respuestas de evocación o fluidez de categoría semántica de frutas y animales y categoría fonológica por un sonido específico inhibiendo las interferencias.



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, pero no en atención sostenida, selectiva (distractiva) no acorde a su edad y escolaridad.

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos, pero con una inadecuada velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico.

MEMORIA: Se identifica inadecuada capacidad para evocar información a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal, pero con respuestas promedio en memoria de contenido visual, mejorando la evocación a partir de la repetición, es importante citar que pueden existir respuestas por debajo de lo esperado en codificación, decodificación y evocación – aprendizaje significativo, inadecuados para su edad y escolaridad.

Su capacidad de memoria o spam es de 8 sobre 12, observándose de forma incorrecta el efecto de primacía y recencia, se observaron intrusiones, perseveración, con inadecuada organización serial.

LENGUAJE: Presenta un desempeño por debajo de esperado para su edad y escolaridad en la producción de palabras de acuerdo con una categoría fonológica, con respuestas inferiores en la categoría semántica lo cual puede compensar algunas dificultades.

Existe inadecuada capacidad semántica, vocabulario, de información, existe adecuado seguimiento de instrucciones, inadecuada comprensión (capacidad de entender y procesar información) en ocasiones la respuesta carece de consistencia.

En ocasiones la paciente realiza fuga de ideas, es decir que responde con un tema que no está relacionado, con baja conciencia fonológica, marcadas fallas comprensivas que se agudizan con la lectura.

Se observaron problemas articulatorios muy leves, adecuada nasalización, no se observó hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

Lectura: Existe inadecuada eficiencia lectora, lo que quiere decir que existe alteración en la conversión grafema - fonema, con identificación inadecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación como la b con d, existe sustituciones literales, visuales, semánticas, problemas de lexicalización, con omisiones de letras y segmentos, en ocasiones no reconoce la consonante generando adiciones.

Escritura: Existe inadecuado lenguaje escrito, con anormales respuestas en los procesos de segmentación fonética y recuperación de los grafemas de cada palabra y la destreza manual necesaria para la escritura. No se observa macrografía, inadecuada utilización de signos de puntuación, existe confusión de consonantes, inadecuada pinza trípode. No se observó temblor, rigidez o movimientos involuntarios, omisión, sustitución de consonantes, al igual que confusión.



PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales, aunque se debe señalar que existe un trazo inmaduro, aunque comienza de lo general a lo particular en los detalles le cuesta, su pinza trípode es inadecuada haciendo acomodaciones con la cabeza, no apoya la mano contraria para mejorar la postura y ejecución de tareas.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Cribada con inadecuada regulación conductual, inhibición, inadecuados procesos de análisis e inferencia, semejanzas, calculo, inadecuada planeación y ejecución de acciones, seguimiento de secuencia, organización de la conducta, inadecuada capacidad para la generación de estrategias y procesos de meta cognición.

Existe inadecuada flexibilidad cognoscitiva (le cuesta cambiar de forma rápida de una tarea a otra), inadecuada capacidad para la resolución de problemas, toma de decisiones, verificar y modificar su comportamiento, inadecuado autocontrol, adecuado mantenimiento de la información y su manipulación (working memory), existe inadecuada capacidad de abstracción y categorización de los estímulos, inadecuada capacidad volitiva o de iniciar acciones, necesitando apoyo en el desarrollo de algunas tareas.

Fluidez fonológica y semántica: Existen respuestas inconsistentes en la fluidez semántica, puede irle bien en determinadas categorías, es posible que la inseguridad, miedo a comunicar la limite, teniendo en cuenta las respuestas de fluidez fonológica estuvieron dentro del promedio.

Estas dificultades establecen inadecuada capacidad para generar soluciones nuevas y diferentes con respecto a un problema concreto y complejo, inadecuada capacidad lingüística, acceso al léxico, capacidad de recuperación y amplitud del vocabulario.

Percepción: Adecuados procesos en las habilidades perceptuales de imágenes superpuestas y de cierre visual, lo que establece normal capacidad en el conocimiento generado a partir de un estímulo visual, adecuada habilidad de figura fondo, de reconocer el percepto completando patrones visuales descifrando, diferenciando, entendiendo y relacionando la información visual cuando se presenta segmentada.

Perfil del paciente:

El desempeño global obtenido en el WISC-V sitúa a la paciente en un **rango intelectual inferior al promedio** (CIT = 70), rango límite entre la discapacidad y los problemas de aprendizaje teniendo en cuenta que la inteligencia de borde oscila entre los 70, 71 y 72; evidenciando un funcionamiento cognitivo significativamente por debajo del esperado para su edad y nivel escolar. Los resultados muestran un **perfil cognitivo no heterogéneo**, con solo una área de adecuado nivel de competencia (viso perceptiva), con los demás dominios afectados, lo que indica un patrón de desarrollo neurocognitivo por debajo de lo esperado.



En el dominio **Comprensión Verbal (CV = 62)** se observa un funcionamiento en rango de discapacidad leve, reflejando limitaciones significativas en el uso y comprensión del lenguaje, acceso a vocabulario, formación de conceptos verbales y habilidades de razonamiento mediadas por información previamente aprendida. Estas dificultades sugieren un impacto directo en el aprendizaje escolar dependiente de la mediación lingüística y en la capacidad de abstracción verbal, las cuales se acompañan de fugas de ideas e inconsistencia a la hora de procesar, analizar y responder temas semánticos.

En contraste, el **Razonamiento Visoespacial (RP = 97)** se ubica dentro de un rango promedio, lo que indica preservación de habilidades de integración visomotora, análisis espacial, organización perceptiva, con marcada afectación en **Memoria de Trabajo general (MT = 72)** se ubican dentro de dos rangos por debajo al promedio, lo que indica dificultades para mantener y manipular información simple a corto plazo. Es importante señalar que la parte viso perceptiva, no compensa otras debilidades más profundas de los sistemas cognitivos superiores.

El **Razonamiento Fluido (RF = 85)** se sitúa en un rango medio-bajo, evidenciando limitaciones en la capacidad de inducir reglas, analizar patrones visuales novedosos y resolver problemas no aprendidos previamente. Asimismo, la **Velocidad de Procesamiento (VP = 72)** se encuentra dos rangos por debajo de lo esperado, lo cual compromete la eficiencia atencional, la rapidez perceptual y la capacidad de ejecución en tareas que demandan control visomotor bajo presión temporal.

En los **índices secundarios**, se destaca un rendimiento disminuido en **Memoria de Trabajo Auditiva (IMTA = 63)**, indicando dificultades para retener, organizar y manipular información verbal secuenciada, lo que impacta procesos de aprendizaje, comprensión y resolución de tareas escolares.

El **Índice No Verbal (INV = 84)** se ubica en un rango promedio bajo, señalando un rendimiento limitado en tareas visoespaciales y visoconstructivas cuando se elimina la carga verbal, perfil que sugiere vulnerabilidad en el procesamiento perceptual bajo condiciones complejas o demandantes.

Los índices integrados (**ICG = 73 e ICC = 74**) se posicionan en rangos bajos, confirmando debilidades en razonamiento abstracto, capacidad de integración conceptual, eficacia cognitiva, manejo simultáneo de múltiples demandas y utilización eficiente de recursos cognitivos durante el aprendizaje y la resolución de problemas.

La orientación auto y alopsíquica es adecuada, sin embargo, se identifican alteraciones importantes en los procesos atencionales, especialmente en la atención sostenida y selectiva, con distractibilidad marcada y lentitud en la ejecución bajo demandas temporales.

En el dominio mnésico, se observa un rendimiento inferior a lo esperado en la evocación de información verbal tanto a corto como a largo plazo, acompañado de dificultades en codificación, decodificación y evocación significativa, a pesar de un span atencional normativo. Se evidencian intrusiones, perseveraciones y pobre organización serial, con mayor afectación en la evocación narrativa. La memoria visual se mantiene dentro de parámetros adecuados.

Se identifican alteraciones en el acceso al léxico, vocabulario y procesamiento semántico, junto con dificultades en la fluidez verbal fonológica y semántica, afectando la producción y



recuperación de palabras. La comprensión presenta inconsistencias, aunque se conserva la capacidad para seguir instrucciones simples. No se observan alteraciones estructurales del habla que sean significativas, es importante citar que la lectura como la escritura se encuentran significativamente comprometidas, destacándose fallas en la conversión grafema-fonema, segmentación fonética, recuperación de grafemas y precisión motora fina, lo que se manifiesta en confusiones de consonantes, errores ortográficos y una pinza trípode inadecuada.

Las praxias viso constructivas y las gnosias se mantienen dentro de los parámetros esperados para la edad y escolaridad, lo que sugiere preservación de habilidades perceptuales y constructivas básicas.

El perfil evidencia un **compromiso cognitivo significativo**, caracterizado por dificultades en razonamiento abstracto y verbal, velocidad de ejecución, memoria de trabajo, auditiva y eficiencia cognoscitiva general. Estas limitaciones afectan de manera directa la adquisición de nuevos aprendizajes, la retención de información, el rendimiento académico y la capacidad para adaptarse a demandas escolares crecientes.

Se recomienda implementar **adecuaciones curriculares**, estrategias de enseñanza individualizadas, apoyo permanente en tareas que requieran procesamiento verbal, y programas de **estimulación neurocognitiva** dirigidos a fortalecer las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, el razonamiento verbal y la memoria de trabajo auditiva.

COMPRESIÓN VERBAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VISOESPACIAL: PROMEDIO

RAZONAMIENTO FLUIDO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F819 TRASTORNO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO, acompañado de problemas de lectura y escritura.

CIT DE 71, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL INFERIOR, con necesidad de apoyo, supervisión.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos de comprensión verbal, razonamiento fluido, razonamiento perceptivo, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, comprensión, velocidad de procesamiento, atención, meta memoria, lectura, escritura.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde fonoaudiología, que permita abordar la comprensión verbal compleja, diferencias, analogías, fluidez verbal, semántica y fonológica, comprensión de textos e historias, análisis y síntesis compleja, mejorar el discurso sintáctico, lectura, escritura.



Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde terapia ocupacional, que permita abordar la hiporresponsividad, modulación, regulación del impulso, control.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, desarrollo de asertividad; inoculación de estrés; auto instrucciones; habilidades de afrontamiento; entrenamiento en habilidades sociales.

Vincular a los padres mediante psicoeducación y sensibilización, como acompañamiento de la menor en sus dificultades, y orientarla en el manejo de estas.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales.

PLAN DE INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA.

1. Objetivo General

Fortalecer los procesos cognitivos alterados —principalmente razonamiento verbal, memoria de trabajo auditiva, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y habilidades lingüísticas— con el fin de mejorar la capacidad de aprendizaje, la adaptación escolar y la autonomía funcional, teniendo como base las fortalezas viso perceptivas preservadas.

2. Objetivos Específicos por Dominio Cognitivo

2.1. Comprensión y Razonamiento Verbal

- Mejorar el acceso al vocabulario, la comprensión semántica y la organización del lenguaje.
- Favorecer la formación de conceptos verbales y la capacidad de razonamiento mediado por lenguaje.
- Reducir la inconsistencia en la comprensión y las fugas de ideas al procesar información.

2.2. Memoria de Trabajo Auditiva y Procesamiento Verbal

- Incrementar la capacidad para retener, manipular y recuperar información verbal secuenciada.
- Optimizar procesos de codificación y evocación significativa.
- Reducir intrusiones, perseveraciones y desorganización serial.

2.3. Atención Sostenida, Selectiva y Velocidad de Procesamiento

- Aumentar la eficiencia atencional ante tareas prolongadas.
- Disminuir distractibilidad y tiempos lentos de ejecución.
- Mejorar la rapidez perceptual y visomotora bajo presión temporal.

2.4. Funciones Ejecutivas

- Fortalecer la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la planeación y la organización secuencial.
- Optimizar la capacidad de resolución de problemas, razonamiento abstracto y toma de decisiones.
- Favorecer el desarrollo de estrategias metacognitivas.



2.5. Lectura y Escritura

- Mejorar la conversión grafema–fonema, segmentación fonética y acceso al léxico escrito.
- Reducir confusiones de consonantes y errores ortográficos.
- Favorecer la motricidad fina, la pinza trípode y la precisión del trazo.

3.2. Intervención Neuropsicológica Cognitivo que pueden hacer apoyar los padres en casa.

A. Memoria de Trabajo Auditiva

- Series de dígitos directos e inversos con apoyo visual progresivamente retirado.
- Ejercicios de "actualización verbal": recordar los últimos elementos de una cadena.
- Actividades de repetición significativa (listas temáticas).
- Tareas duales simples (p. ej., repetir palabras mientras realiza golpecitos rítmicos).

B. Atención y Velocidad de Procesamiento

- Entrenamiento en tareas de atención sostenida (barrido de estímulos, detección de objetivos).
- Actividades de atención selectiva con distractores visuales y auditivos controlados.
- Ejercicios de velocidad visomotora (copias, trazos, búsqueda rápida).
- Software de estimulación cognitiva estructurada, si está disponible.

C. Funciones Ejecutivas

- Tareas de inhibición (Go/No-Go, Stroop adaptado).
- Actividades de flexibilidad cognitiva (clasificación por reglas cambiantes).
- Ejercicios de planeación (torre de Hanoi, laberintos secuenciales).
- Resolución de problemas con apoyo verbal estructurado.
- Entrenamiento metacognitivo:
 - auto instrucciones,
 - verbalización de pasos,
 - anticipación y verificación de resultados.

3.1. Intervención en Lenguaje (Fonoaudiología)

- Ejercicios de ampliación léxica mediante categorías semánticas, asociaciones y campos conceptuales.
- Actividades de comprensión de instrucciones de complejidad creciente.
- Trabajo en fluidez verbal fonológica y semántica, con apoyo visual.
- Lectura guiada con:
 - Métodos multisensoriales (fonema–grafema).
 - Tarjetas visuales y apoyos pictográficos.
 - Repetición controlada con retroalimentación inmediata.
- Escritura estructurada:
 - dictado por segmentos,
 - discriminación auditiva de fonemas,
 - reconstrucción de palabras,
 - ejercicios de motricidad fina para mejorar la pinza y el trazo.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que



curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Tener en cuenta que sus respuestas pueden carecer de consistencia.

Permítale recuperar los exámenes con talleres o repitiendo exámenes, sin dejar de exigirle, pero teniendo en cuenta sus limitaciones.

Utilice un lenguaje claro, mensaje corto y apoyo en lo visual y auditivo.

Dele un poco más de tiempo para las tareas.

Refuerce las conductas positivas.

Siente cerca al docente.

3.3. Intervención Académica y Escolar.

Ajustes Curriculares Recomendados.

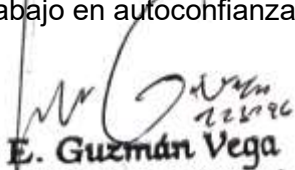
- Adecuaciones no significativas, con énfasis en:
 - reducción de carga verbal,
 - instrucciones por pasos,
 - más tiempo en las evaluaciones,
 - material visual de apoyo,
 - actividades prácticas y concretas.
- Presentación de tareas mediante esquemas, pictogramas y ejemplos visuales.

Estrategias de Enseñanza Individualizada

- Uso de organizadores gráficos.
- Enseñanza explícita y modelada paso a paso.
- Repetición espaciada para favorecer almacenamiento a largo plazo.
- División de actividades extensas en segmentos cortos y manejables.

3.4. Intervención Emocional y Conductual

- Entrenamiento en tolerancia a la frustración ante tareas de alta demanda cognitiva.
- Refuerzo positivo basado en logros pequeños y progresivos.
- Rutinas estructuradas para reducir la distractibilidad.
- Trabajo en autoconfianza y autoeficacia académica.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P. 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional: 123096

Certificado internacional en ADOS 2

